

Fibrilação atrial · ritmo e anticoagulação

Na FA, primeiro estabilize (ABC e frequência). Depois decida anticoagulação pelo risco embólico e escolha controle de frequência versus ritmo conforme duração, sintomas e risco de trombo.

Instabilidade = cardioversão

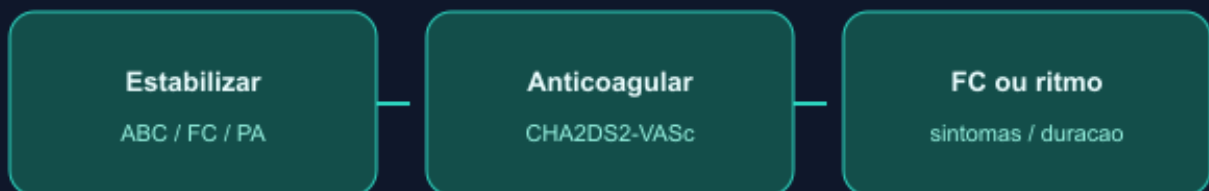
Lembre - Instabilidade = cardioversão

Hipotensão, choque, isquemia miocárdica, EAP ou rebaixamento atribuíveis à FA !' cardioversão elétrica sincronizada sem atrasar por jejum/anticoagulação plena se risco de vida.

Fluxo de prova: tratar instabilidade primeiro; anticoagulação é decisão paralela ao controle de FC/ritmo.

Abordagem da FA

Estabilizar -> anticoagular -> estrategia



Controle de frequência (estável)

- Betabloqueador ou antagonista de cálcio não-di-hidropiridínico (diltiazem/verapamil) se FE preservada
- Digoxina: útil em IC/hipotensão relativa; menos eficaz no esforço
- Amiodarona EV: opção quando há IC com FE reduzida e necessidade de controle
- Alvo usual de FC em repouso ~ <110 bpm na estratégia leniente, se assintomático

Anticoagulação — visão de prova

Cenário | Conduta típica

CHA₂DS₂-VASc "e2 &B / "e3 &@ | Anticoagular (DOAC preferencial se elegível)

FA "e48 h ou duração incerta | Anticoagular "e3 sem antes de cardioversão eletiva (ou ETE sem trombo)

Pós-cardioversão | Anticoagular "e4 sem se risco elevado / duração longa

Valvulopatia reumática/prótese mecânica | Varfarina (não DOAC)

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não cardioverta eletivamente FA de duração >48 h sem anticoagulação adequada ou exclusão de trombo atrial (ETE). Risco de embolia sistêmica é clássico em R1.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1